

基于Glazer评估的方案制定

目 录

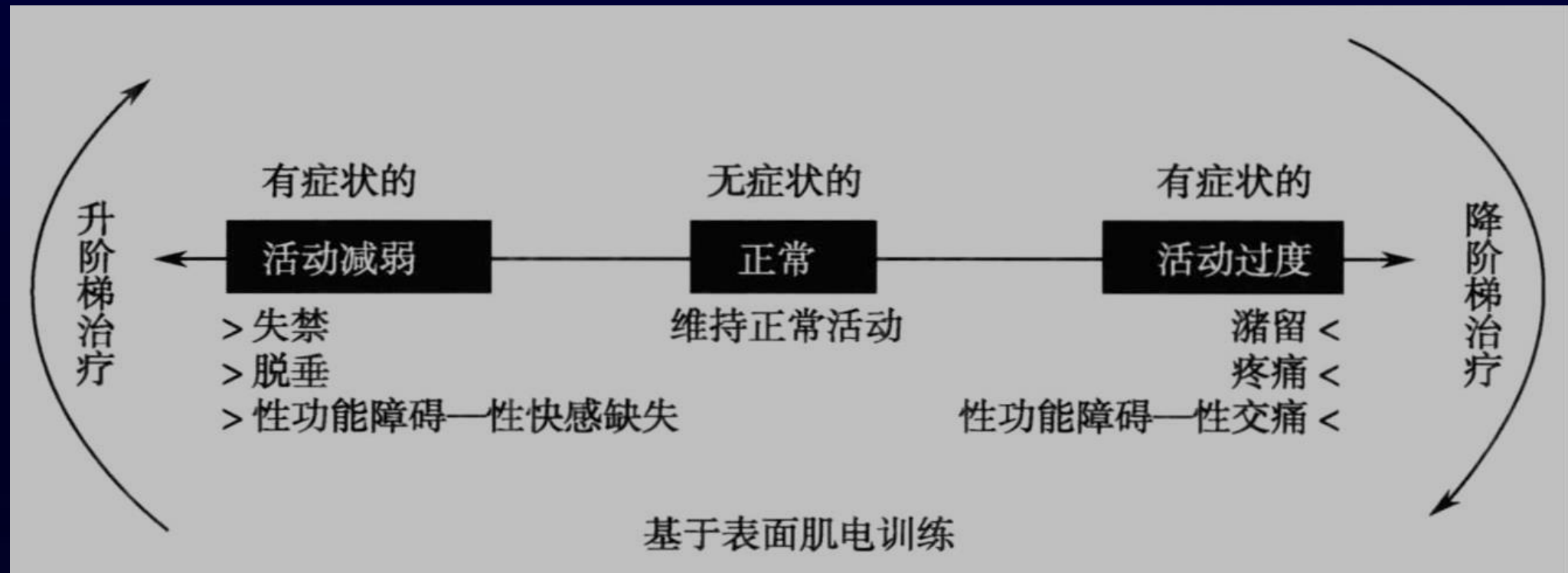
01 基于**Glazer**评估的治疗原则

02 基于**Glazer**评估的方案制定

01

基于Glazer评估的治疗原则

治疗方案需要根据盆底肌电类型选择



强化

协调

放松

病史采集

- 主诉
- 现病史
- 既往史
- 孕产史
- 家族史

查 体

- 全身检查
- 妇科检查
- POP-Q分级
- 盆底肌筋膜触诊和疼痛点检查

辅助检查

- 阴道分泌物
- 尿常规/细菌培养
- TCT和HPV检查
- Glazer评估
- 尿流动力学、B超、MRI、膀胱镜等

02

基于Glazer评估的方案制定

1.活动减弱（松弛型）

肌电值

静息基线正常或过低

快速收缩
紧张收缩
耐力收缩



放松时间

正常

变异性

耐力收缩稳定性差

1.活动减弱型（松弛型）

至少两个疗程，**10次/疗程，每周3-5次**

第一疗程（1-6次）

神经肌肉电刺激10-15分钟+Kegel模板训练15分钟

第一疗程（7-10次）

肌电触发电刺激10-15分钟+Kegel模板训练15分钟

第二疗程及以后

肌电触发电刺激10-15分钟+Kegel模板训练15分钟

两疗程间最多休息一周

1.活动减弱型（松弛型）

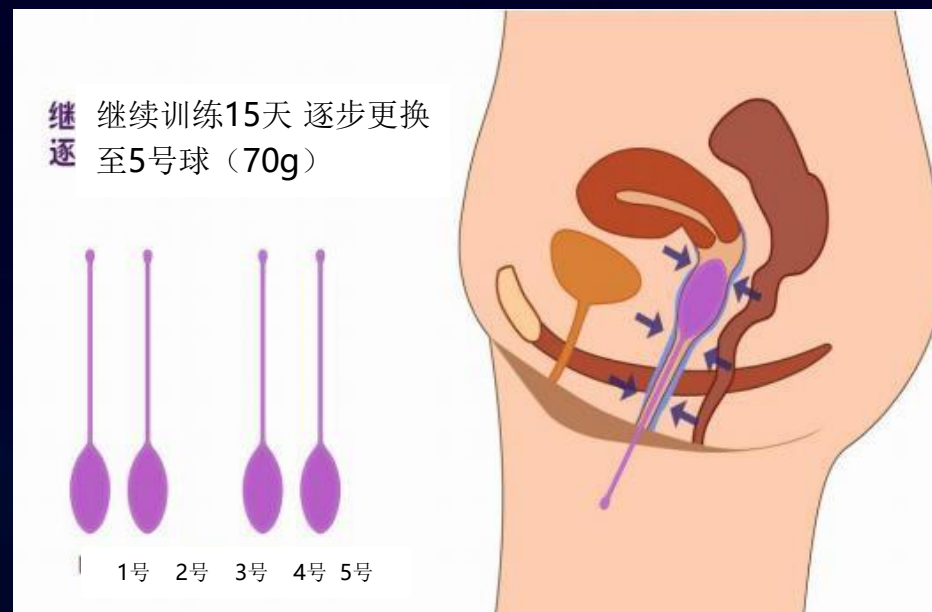
1. 重度松弛（Glazer评估紧张收缩阶段，即第三步肌电值 $<15\mu\text{V}$ ）：
初期注重神经肌肉电刺激治疗，辅以Kegel训练
2. 轻、中度松弛（Glazer评估紧张收缩阶段，即第三步肌电值 $\geq 15\mu\text{V}$ ）：肌电触发电刺激，加强Kegel训练

活动减弱肌肉导致的症状明显，无疼痛、压痛、急迫性尿失禁等症状，
可选择压力性尿失禁、轻度肌肉松弛方案参数是一样的，都是50Hz方案

以脱垂为主要症状的，可选择轻度器官脱垂

1.活动减弱型（松弛型）

3. Kegel模板高度为Glazer评估第三步均值的**50%-80%**。之后，根据患者的恢复情况，适当调整训练模板难度。（注意变异性）
4. **家庭训练**同样重要，配用阴道哑铃进行家庭盆底肌训练效果更好



1.活动减弱（松弛型）

5. 如患者有**焦虑紧张等心理问题**，可在治疗前进行**5-10分钟**的放松：
音乐放松、多媒体放松、呼吸放松

症状为**肌肉松弛症状**，如压力性尿失禁、脱垂、阴道松弛等，但是**静息基线比较高**，就要考虑是否为患者精神心理因素、体位因素、电刺激对阴道粘膜刺激等因素造成的暂时性肌肉张力过高。经过**引导式放松**，适应一段时间后，静息肌电恢复正常。

但仍有一部分患者不能恢复正常，对于这类患者，**仍然按照肌肉松弛治疗**，**并教其学会放松盆底肌肉**。

2.活动过度型

肌电值

静息基线增高

放松时间

收缩后放松
时间明显延
长



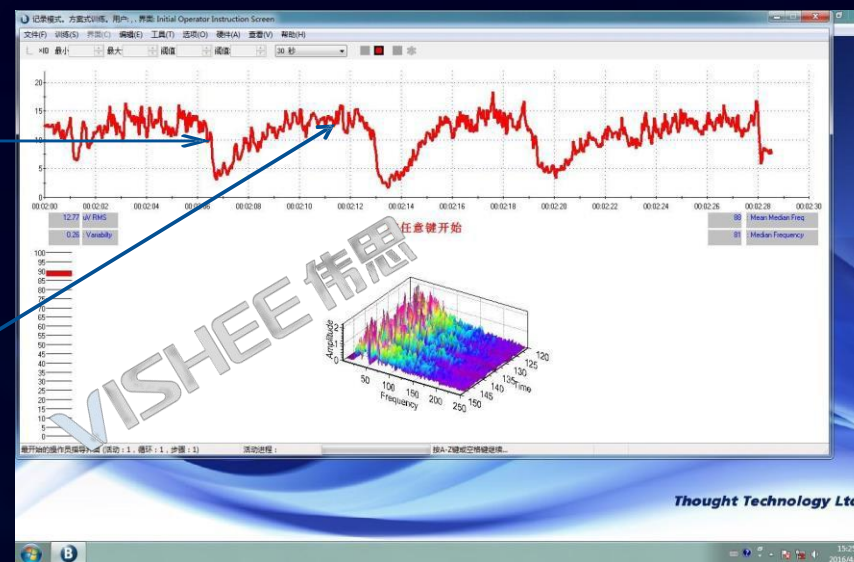
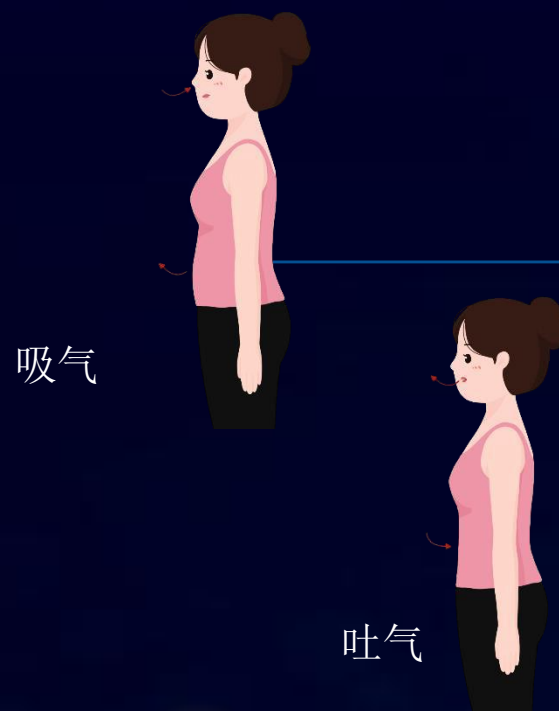
变异性

静息肌电稳定性差
耐力收缩稳定性差

2.活动过度型

至少两个疗程，**10次/疗程**，每周**3-5次**

呼吸放松10分钟+Kegel模板训练15分钟



2.活动过度型

1. 选择**合适的放松模式**（音乐放松、多媒体放松、呼吸放松），无论选择哪种放松模式，都要配合腹式呼吸
2. 如果患者依从性差，强烈需要电刺激治疗，则可使用“盆底痛”，电流强度为有感觉即可（**低频低电流短时**）
3. **Kegel**模板高度为**Glazer**评估第三步均值的**30%-50%**。之后，根据患者的恢复情况，适当调整训练模板难度
4. 可结合盆底**肌筋膜手法治疗**

2.活动过度型

首先需要考虑患者的临床症状，患者存在盆底痛、性交痛等症状，按照过度活动的方案治疗。

盆底肌挛缩的肌电表现：有一部分病程较长的盆底痛患者，由于盆底肌损伤过于严重，导致盆底肌肉出现挛缩，由于肌纤维的肌电活动很微弱，其肌电表现与松弛型盆底一致。对于这类患者，要从病史、指检以及电生理等多个方面进行综合诊断。

3.混合型

先按照活动过度型盆底肌治疗



再按活动减弱型治疗



最后练习盆底肌协调稳定的协调运动

4.膀胱过度活动症（OAB）、急迫性尿失禁

肌电活动正常

合并活动减弱型
盆底功能障碍

合并活动过度型
盆底功能障碍

4.OAB/急迫性尿失禁+肌电活动正常

按OAB、急迫性尿失禁治疗，至少两个疗程，10次/疗程，每周3-5次

神经肌肉电刺激（OAB/急迫性尿失禁）10-15分
钟



Kegel模板训练15分钟

4.OAB/急迫性尿失禁+活动减弱型

按OAB、急迫性尿失禁治疗，至少两个疗程，10次/疗程，每周3-5次



OAB、急迫性尿失禁症状缓解后，按松弛型盆底治疗，10次/疗程，每周3-5次

4.OAB/急迫性尿失禁+活动过度型

按活动过度型盆底功能障碍治疗，至少两个疗程，10次/疗程，每周3-5次



活动过度型盆底功能障碍缓解后，治疗OAB/急迫性尿失禁，至少两个疗程，10次/疗程，每周3-5次

5.注意事项

- (1) 治疗过程中出现与前次治疗明显不同的表现，比如出现明显刺痛，需考虑是否有感染、炎症、水肿等出现；
- (2) 患者盆底肌放松时基线明显升高，出现活动过度的表现；
- (3) 患者治疗过程中，改善明显，可适度调高模板。

感谢您的观看